Azienda Ospedaliera Euganea
U.O.C. Neurologia - Centro Disturbi del Movimento
Direttore: Prof. Ottavio Schiavon

Via San Massimo 74
35129 Padova
Segreteria 049 8217455
cdm.neurologia@aoeuganea.example.it

Referto di visita neurologica

Visita di controllo (cod. 89.01) - Ambulatorio malattia di Parkinson e parkinsonismi

ASSISTITA

Cognome e nome:	**Pavan Luciana**	Data di nascita:	**09/03/1952**
Codice fiscale:	**PVNLCN52C49G224K**	Tessera sanitaria:	**80380150155091177245**
Indirizzo:	**Via Chiesanuova 18, 35136 Padova**	Esenzione:	**038.332**

Data visita:	07/10/2024	N. referto:	NEU-24-11872
Prenotazione:	CUP-PD-2024-338901	NRE:	050A40762280931
Inviata da:	Dott. Ivo Zorzi (MMG)	Classe di priorità:	P

Referto: NEU-24-11872

ANAMNESI

La sig.ra Pavan, di 72 anni, ex insegnante di scuola primaria in pensione, è seguita presso questo Centro dal 2019 per malattia di Parkinson idiopatica ad esordio con tremore all'arto superiore destro. Giunge accompagnata dal marito, sig. Renzo Bortolami, che collabora all'anamnesi.
Dall'ultima visita (03/04/24) la pz. riferisce fluttuazioni motorie con esaurimento dell'effetto della dose di levodopa dopo circa 3 ore, discinesie di picco lievi, non invalidanti, e brevi episodi di freezing della marcia nei passaggi stretti. Il sig. Bortolami segnala vocalizzazioni e movimenti bruschi durante il sonno, compatibili con disturbo comportamentale in sonno REM. Stipsi cronica. Riferita una caduta a domicilio il 14/08/2024, senza fratture. Non allucinazioni, non disturbi del controllo degli impulsi.

TERAPIA IN ATTO

Farmaco	Posologia	Orari
Levodopa/carbidopa 100/25 mg	1 cp x 4/die	7 - 11 - 15 - 19
Pramipexolo RP 1,05 mg	1 cp/die	ore 8
Rasagilina 1 mg	1 cp/die	ore 8
Macrogol 13,8 g	1 bustina/die	al bisogno

ESAME OBIETTIVO NEUROLOGICO

Esaminata in fase ON, circa 90 minuti dopo l'assunzione della dose delle 11. Vigile, orientata, eloquio ipofonico. Facies ipomimica. Bradicinesia prevalente a destra alle prove di tapping e di apertura-chiusura della mano. Rigidità plastica di grado lieve-moderato ai quattro arti, con segno della ruota dentata a destra. Tremore a riposo all'arto superiore destro, di bassa ampiezza. Riflessi osteotendinei normoevocabili e simmetrici, Babinski negativo bilateralmente. Marcia a piccoli passi con ridotta pendolarità degli arti superiori, girata in 4 passi; pull test con 2 passi di retropulsione, recupera autonomamente.
PA in clinostatismo 136/82 mmHg, in ortostatismo dopo 3 minuti 118/74 mmHg.

Scala di valutazione	Punteggio	Visita precedente
MDS-UPDRS parte III (fase ON)	31	26

Scala di valutazione	Punteggio	Visita precedente
Stadio di Hoehn e Yahr	2,5	2,0
MoCA (corretto per scolarità)	25/30	27/30

CONCLUSIONI E INDICAZIONI

Quadro di malattia di Parkinson idiopatica in progressione (stadio di Hoehn e Yahr come da tabella), con fluttuazioni motorie di tipo wearing-off e lieve ipotensione ortostatica.

Modifiche terapeutiche:

- frazionare la levodopa in 5 somministrazioni (levodopa/carbidopa 100/25 mg alle ore 7 - 10 - 13 - 16 - 19), a distanza di almeno 1 ora dai pasti proteici;
- introdurre opicapone 50 mg 1 cp la sera al momento di coricarsi;
- proseguire pramipexolo e rasagilina invariati.

Indicazioni: fisioterapia neuromotoria con esercizi per il freezing (cicli di 10 sedute); valutazione logopedica per l'ipofonia; idratazione adeguata e cauti cambi di postura. Rimuovere i tappeti e installare maniglioni in bagno per ridurre il rischio di cadute.

Il marito è informato dei segni di allarme (cadute ripetute, allucinazioni, confusione) per cui contattare il Centro.

Prossimo controllo: tra 4 mesi, con diario motorio compilato dalla pz. e dal sig. Bortolami.

Visita eseguita con la collaborazione della Dott.ssa Marta Carraro, medico in formazione specialistica in Neurologia.

Il Dirigente Medico Neurologo

Dott. Enrico Zanella

Dott. Enrico Zanella
Specialista in Neurologia
Iscr. Ordine dei Medici n. PD-07731

Padova, 07/10/2024